

Anatomie de l'appareil uro-génital

Diapositive 1

ANATOMIE DE L'APPAREIL
URO-GENITAL

ENSEIGNANT

:Dr VALENTIN

ECRIT PAR

:BERAL SERGE/MEDECINE II

§Tout arrive au point a qui sait attendre§

vendredi 8 juillet 2016

Diapositive 2

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 3

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 4

(pas de texte extrait sur cette diapositive)

Diapositive 5

Chapitre 1

LES REINS

1-DEFINITION

Le rein est un organe pair,
rétropéritonéal
qui sécrète des urines.

2-SITUATION ANATOMIQUE

Au nombre de deux, les reins sont situés dans la partie supérieure de la fosse lombaire et sont orientés par leur grand axe, oblique en bas et dehors. Le rein droit est étendu du disque intervertébral D11-D12 jusqu'à la partie moyenne du corps vertébral de L3. Le rein gauche, plus haut, est étendu de la moyenne de D11 jusqu'au disque L2-L3.

3-CONFIGURATION EXTERNE

3.1-MORPHOLOGIE

BERAL

Diapositive 6

Le rein à la forme d'un haricot à hile interne au travers duquel passent les vaisseaux et l'uretère. Aplati

d'avant en arrière, il est allongé presque verticalement, le grand axe oblique en bas et latéralement. Il présente: 2 faces, 2 bords et 2 pôles.

3.2-DIMENSION MOYENNE

longueur: 12cm

Largeur: 6cm

épaisseur: 3cm

3.3-AUTRES CARACTERISTIQUES

Couleur: sombre rouge

Consistance: ferme (permet la suture chirurgicale)

Diapositive 7

3.4-ANOMALIES

Variation de forme

Situation: reins ptose ou ectopique

Nombre: rein unique

Symphyse des deux reins(rein à cheval)

4-CONFIGURATION INTERNE

De dedans en dehors sur une coupe frontale, on retrouve:

Le sinus rénal: constitué de vaisseaux rénaux et des calices(8-10)

Le parenchyme qui présente:

.

Diapositive 8

la zone médullaire formée de pyramides de Malpighi au nombre de 8-10 par rein. Au sommet de chaque pyramide s'ouvre la papille. Au tour de chaque papille s'insère un calice. Entre chaque pyramide se trouve la colonne de Bertin.

La zone corticale ou périphérique constituée de lobules corticaux, colonne de Bertin et le cortex formé par la capsule de Bowman.

La capsule: membrane fibreuse et résistante.

5-la fixité

Les moyens de fixité du rein sont:

la loge rénale

Le

rein

est

contenu dans une loge fibreuse limitée par un fascia

Diapositive 9

comportant deux feuillets(antérieur mince et postérieur épais
appelé
fascia de
Zuckerkandel

).I La glande surrénale est comprise dans la
meme

loge main séparée du rein par une cloison fibreuse
intersurrénale.Elle

ne suit pas le rein en cas de ptose et reste en place en cas de néphrectomie.

en outre, le rein est maintenu en place par les vaisseaux(
pédicule

rénal),les pressions exercées par la masse viscérale en avant et la tonicité des muscles de la paroi
postérieure en arrière.

6-RAPPORTS

le rein et la graisse qui l'entoure sont situés dans la loge limitée par le fascia périrénal. Par
l'intermédiaire de cette loge, le rein est en rapport avec:

Diapositive 10

en arrière: la paroi thoracique et la plèvre en haut, la paroi lombaire en bas

En avant:

à droite: face inférieure du lobe droit du foie, l'angle colique droit et le 2eme duodénum

à gauche: le colon transverse, la face

inféro

-interne de la rate, le corps et la queue du pancréas.

En dedans: la veine cave inférieure à droite et l'aorte à gauche.

7-VASCULARISATION ET INNERVATION

7.1-ARTERES RENALES

Les artères rénales assurent la vascularisation des reins, une partie de la

Diapositive 11

surrénale et la partie initiale des uretères

A- ORIGINE

Les artères rénales naissent de la face latérale de l'aorte au niveau de L1. la gauche est née souvent un peu plus bas.

B-TRAJET

Elles sont obliques, latéralement en bas et en arrière. L'artère rénale gauche est 3-4cm et celle droite est plus longue(6-7cm). Elle contourne par en arrière la veine cave inférieure.

C-TERMINAISON

Il n'existe aucune anastomose entre les branches de divisions. Ce sont les artères terminales.

Diapositive 12

C.1-SINUS

Dans le sinus du rein, la disposition est très variable. Le plus souvent il existe:

une branche antérieure prépyélique qui se divise en 3-4 rameaux

vascularisant

la partie antérieure du rein et donne une artère pour l'extrémité inférieure du rein.

Une branche postérieure

réropyélique

qui contourne le bassinet par en arrière, se divise en 3-5 rameaux,

vascularise

la partie postérieure du rein et donne une artère pour l'extrémité supérieure du rein.

C.2-DANS LE PARENCHYME

Les branches de terminaison des artères pré et

réropyéliques

pénètrent

Diapositive 13

entre les papilles (branches interpapillaires) puis cheminent entre les pyramides (branches pyramidales). Les branches se terminent à la base du pyramide en constituant une corbeille vasculaire appelée artère arquée d'où partent perpendiculairement les artères interlobulaires.

D-BRANCHES COLLATERALES

les artères colla sont:

les artères

capsulo

-adipeuses

vascularisant

la graisse

périrénale

L'artère surrénale inférieure

Les artères

pyélo

-

urétériques

destinées au bassinet et à la partie proximale de l'uretère. Ses rameaux colla s'anastomosent entre eux et avec les artères de voisinage (art. phrénique) constituant ainsi l'arcade

exorénale

.

Diapositive 14

E-VARIATIONS

Elles peuvent intéresser:

le

nombre

des artères: dans 1/3 de cas, il existe une artère rénale double d'un côté ou parfois 3-4 du même côté.

Le niveau d'origine : plus ou haut sur l'aorte depuis la partie initiale de l'aorte abdominale jusqu'au 1^{er}

cm des artères iliaques communes.

Le trajet et longueur (artère horizontale).

La terminaison plus ou moins précoce et la distribution parenchymateuse.

NB: ces anomalies sont à considérer avant toute artériographie rénale (examen qui permet de voir la vascularisation artérielle).

Diapositive 15

7.2-LES VEINES RENALES

a-Origine

Les veines rénales naissent au bord médial du rein par confluence des veines péricalicielles. Ces

vv

drainent elles même les

vv

pyramidales et les

vv

et les veines interpapillaires. Dans le sinus du rein, elles sont situées en deux plans pré et rétro-pyélique. Le réseau pré-pyélique étant bcq plus important.

b-trajet

Il diffère selon le côté:

à droite, elle est courte(3cm) et horizontale.

à gauche elle est longue(6cm) et oblique en haut vers la ligne médiane. Elle décrit une

Diapositive 16

courbe à concavité postérieure croisant par devant l'aorte juste au dessous de l'aorte mésentérique sup. Elle forme la limite inférieure d'un quadrilatère veineux limité en outre par la veine mésentérique inférieure et le plan splénomésentérique.

C-TERMINAISON

Les veines rénales se jettent dans la veine cave

inf

:

à droite à un angle presque = 90°

À gauche selon un angle aigu ouvert en bas.

D-COLLATERALES

de deux cotés:

Diapositive 17

Les

vv

surrénales inférieures

Les

vv

capsulo

-adipeuses

Les

vv

pyélo

-

urétériques

à gauche :

La veine gonadique

La veine surrénale principale

E-ANASTOMOSE

 dans le parenchyme rénal par une large voute veineuse sous pyramidale.

Dans l'atmosphère par une arcade veineuse

exorénale

connectée aux

vv

coliques, urétériques et phréniques inf.

Diapositive 18

L'anastomose avec les

vv

azygos est importante et constitue le tronc azygos lombaire à gauche.

7.3-LES LYMPHATIQUES

Les collecteurs d'origine suivent les vaisseaux sanguins.

7.4-LES NERFS

Ils proviennent du plexus solaire. Le plexus rénal a pour origine:

Les ganglions cœliaques

Les ganglions mésentériques sup

Les ganglions aortico-rénaux

Le nerf petit splanchnique et splanchnique

inf

Diapositive 19

Les rameaux nerveux se répartissent en deux plans antérieurs et postérieurs .

CONCLUSION

Les reins sont deux organes pairs situés dans le rétropéritoine. Ils ont des rapports étroits avec des organes de voisinage. La

connaissance

de l'anatomie du rein est importante pour les variations anatomiques et prise en charge chirurgicale des pathologies rénales.

Diapositive 20

CHAPITRE2

LES URETERES

1.DEFINITION

Les uretères sont deux long conduits musculo-membraneux, contractiles qui conduisent l'urine sécrété par les rein du bassinet à la vessie .

2.TRAJET D'ENSEMBLE ET SITUATION

Diapositive 21

a-origine

L'uretère fait suite à la partie

inf

du bassin en regard du processus transverse de L2.

b-trajet

Bien individualisé sur une uiv, l'uretère comporte plusieurs parties:

partie abdominale: verticalement descente jusqu'au détroit sup et comporte deux segments:
segment sup(ou lombaire) et segment

inf

(ou iliaque).

Partie pelvienne: elle comporte 3 segments notamment viscéral, pariétal et vésical.

Diapositive 22

C-TERMINAISON

L'uretère s'ouvre dans la vessie à l'
ostium
de l'uretère(
meat
urétéral).

NB: Finalement les deux uretères sont distant de 8cm à leur origine et de 2cm à la terminaison.

3-DIMENSION

longueur :24-32cm

- partie

abdo

:12-14cm dont 9-10cm pour le segment lombaire et 3-4cm pour cl8 iliaque.

-partie pelvienne:12-18cm dont 1.5cm seulement pour le segment vésical.

diamètre:3-5cm avec deux rétrécissements.

Diapositive 23

4-MOYENS DE FIXITE

L'uretère est relativement mobile mais maintenu en place par:

Ses deux extrémités(bassin et vessie)

Son adhérence à la face postérieure du péritoine pariétal postérieur.

En haut au bord médial de l'extrémité

inf

du rein(ligament inter-
ureterorenal

).

5-STRUCTURE

L'uretère est constitué de 3 tuniques dont de dehors en dedans:

adventice:conjunctivo-elastique ou cheminent vaisseaux et nerfs.

musculaire: lisse avec deux couches(

int

et

ext

).

muqueuse: lisse en continuité en bas avec la muqueuse vésicale.

Diapositive 24

6-RAPPORTS

l'uretère traverse plusieurs conduits anatomiques:

Segment lombaire vertical ou légèrement oblique en bas et en dedans. Il répond en avant au péritoine et en arrière au muscle psoas. Il est croisé sur sa face antérieure au niveau de L3 par les vaisseaux spermatiques.

Segment iliaque: il se projette en dedans des articulations sacro-iliaques. Il décrit une courbe concave en arrière sur la

la

saillie des vaisseaux iliaques. L'uretère droit

xse

la face

ant

de l'artère iliaque

ext

et l'uretère

gche

xse

la face

ant

de l'artère iliaque commune.

Segment pelvien: il décrit une courbe concave en avant et en dedans:

Diapositive 25

-à sa terminaison, l'uretère traverse la paroi vésicale obliquement en bas, en avant et en dedans.

-les méats urétéraux ont des formes variables: ovalaire, en fente oblique en bas et en dedans, arrondie, ponctiforme.

7-VAISSEAUX ET NERFS

7.1-ARTERES

De haut en bas, elles proviennent successivement des artères: artère rénale, gonadiques(testiculaire ou varoque),iliaque commune et interne,génito-vésicale chez l'homme ou utérines chez la femme.

Diapositive 26

7.2-LES VEINES

Calquées sur les artères, elles gagnent les

vv

:

Rénales

Gonadiques

Iliques internes et leurs affluents

7.3-LYMPHATIQUES

Ils sont tributaire des nœuds lymphatiques:

Abdomino

-

latéro

-aortiques

Iliques communes externes

Diapositive 27

Iliques communes et internes.

Ils sont largement anastomosés avec les lymphatiques du rein en haut et ceux de la vessie en bas.

7.4-LES NERFS

Accompagnant les artères, ils proviennent du plexus rénal, plexus testiculaire ou ovarique et du plexus hypogastrique inf

.

8-ANOMALIES

Elles sont extrêmement fréquentes. Il peut s'agir:

d'une absence d'uretère s'accompagnant d'une agénésie rénale homolatérale.

D'une artère borgne en haut ou en bas;

Diapositive 28

D'une uretère double(uretère bifide)

d'un abouchement ectopique(intra ou extra vésical).

Ces anomalies se rencontrent surtout en cas de duplicité urétérale.

CONCLUSION

L'uretère est un long conduit qui traverse plusieurs régions avec des rapports étroits aux organes voisins. Il présente des rétrécissements qui sont souvent le siège de lithiase.

Les malformations sont également fréquentes. D'où la
knce

anatomique normale de l'uretère s'avère nécessaire.

Merci

!

Diapositive 29

CHAPITRE3

LA VESSIE

1-DEFINITION

la vessie est un réservoir musculo-membraneux destiné à contenir l'urine entre chaque miction.

2-SITUATION ANATOMIQUE

La vessie est située dans la loge antérieure du pelvis:

Diapositive 30

Au dessous du péritoine

En arrière de la symphyse pubienne

En avant de l'appareil génital chez la femme et en avant du rectum chez l'homme

Au dessus de la partie antérieure du plancher périnéal

Elle repose sur la prostate chez l'homme

et sur le vagin chez la femme

Chez l'embryon et le

nouveau-né, elle

est en situation

bcq

plus haute

rependant

en grande partie à la partie abdominale.

3.DIMENSSIONS ET CAPACITES

3.1-VESSIE VIDE

Diamètre

antéro-postérieure

:5-6cm

Diapositive 31

Diamètre transversal:7cm

3.2-VESSIE PLEINE

Diamètre

antéro-postérieur

:6-10cm

Diamètre transversal:8-10cm

3.3-CAPACITE

Capacité physiologique:300-350ml

Capacité maximale:2-3l si la distension se fait lentement

4-CONFIGURATION EXTERNE

Sa forme dépend de son état de réplétion ou de vacuité :

Diapositive 32

4.1-VESSIE VIDE

Elle à la forme d'une cupule avec 3 faces,3 bords et 3 angles:

Les faces: sup(dorsale),

antéro

-inférieure(ventrale) et postéro-

inf

(base).

Les bases:2 bords latéraux et un bord postérieur

Les angles: un angle antérieur ou apex et 2 angles postéro-latéraux.

4.2-VESSIE PLEINE

Elle tend à prendre une forme globulaire ovoïde à grosse extrémité postéro-sup:

Sa face s'élève en dôme

Ses bords latéraux se distendent et deviennent des faces alors que sa base est fixe.

Diapositive 33

5-CONFIGURATION INTERNE

Elle peut être étudiée par la cystoscopie.

Surface interne: elle est rosée chez le vivant et grisâtre sur le cadavre; lisse chez l'enfant et aréolaire chez l'adulte.

3 orifices apparaissent au niveau de la base de la vessie:

Ostium

urétral(col de la vessie) situé à la partie médiale et antérieure de la base.

Méats urétéraux(ou ostiums urétéraux):symétrique, elliptique, oblique en bas et vers la ligne médiane.

Ces orifices permettent de distinguer 3 parties à la base de la vessie:

Diapositive 34

Le trigone vésical ou trigone de LIEUTAUD limité par ces 3 orifices réunis par des bourrelets

Le bas fond vésical situé en arrière du plis inter-urétérique

.

6-STRUCTURE

La vessie est constitué de 3 tuniques superposées:

Tunique externe ou adventice

Tunique musculaire lisse(

détrusor

) avec 3 couches.

Tunique muqueuse.

7-MOYENS DE FIXITES

nombreux mais assez peu

efficace.Ce

sont:

Diapositive 35

Chez l'

homme:

continuité avec l'urètre prostatique

Chez la femme: le vagin lui-même et le muscle élévateur de l'anus

Dans les deux sexes: les ligaments pubo-vésicaux, les cordons fibreux et la loge vésicale.

8.LES RAPPORTS

8.1-LA LOGE VÉSICALE

La vessie est contenue dans une loge ostéocartilagineuse incomplète constituée par:

En avant et latéralement: le fascia ombilico-prévésical

Diapositive 36

En bas et latéralement: la partie antérieure de la lame sacro-recto-génito

-pubienne

En haut: le péritoine

En arrière:

chez l'

homme: la

lame

prostatato

-

peritoneale

de DENOUVILLIERS

Chez la femme: aucun fascia nettement individualisé. Vessie et vagin sont simplement séparés par une lame tissulaire assez lâche(septum

vesico

-vaginal).

8.2-RAPPORTS DANS LA LOGE

La vessie est séparée de la loge par une épaisse couche de tissu cellulo-conjonctif: la gaine allantoïdienne de DELBET.

Diapositive 37

La loge
vésicale, outre

la vessie:

L'ouraque(cordon fibreux)

Les vaisseaux et nerfs de la vessie

Segment terminal des uretères

Partie pelvienne de l'urètre féminin

8.3-rapports a l'

exterieuR

de la loge

le rapport varie selon l'état de réplétion et selon le sexe.

les rapports de la vessie vide

Face supérieure: est en rapport avec les anses grêles, le
coecum

et l'appendice puis le colon sigmoïde à
gche

.

Diapositive 38

Face

antéro-inf:la

symphyse pubienne et l'espace

prévésical

(espace de RETZUIS)

Apex de la vessie: derrière le pubis surplombé par le péritoine.

La base

Elle présente des rapports différents selon le sexe:

chez l'

hoe:le

segment

ant

crrspdt

au col de vessie et répond à l'urètre prostatique; le segment postérieur

crrspdt

au trigone vésical et répond avant tout à la loge génitale comprise entre les deux feuillets de la lame
prostato

-péritonéale.

Chez la femme: un segment

ant

représentant les 2/3 de la base répondant au vagin et un segment post représentant le 1/3 sup de la
vessie répondant à la portion s/vaginale du col utérin.

Diapositive 39

e-les bords latéraux

Ils sont longés de chaque côté par l'artère ombilicale. Chez l'homme, le canal déférent surplombe le bord latéral de la vessie.

F-bord postérieur

Chez l'homme, il contourne la convexité antérieure du rectum. Chez la femme, il contourne l'isthme utérin et il est situé exactement en regard du fond du cul-de-sac vésico-utérin.

2-rapport de la vessie pleine

lorsque la vessie se remplit, ses parois se distendent. C'est, seules ses parois

Diapositive 40

antéro

-

inf

, sup et latérale se modifient. La vessie devient abdomino-pelvienne.

a-face supérieure et

antéro

-inférieure

La vessie se distend au dépend de sa face antérieure

srtt

sup:

Le péritoine est refoulé et détermine un sac

prévesical

La vessie contracte ainsi les rapports avec la paroi

abdomino

-antérieure autorisant la cystostomie(ouverture de la vessie).

Latéralement, la vessie pleine peut atteindre les régions fémorale et inguinale pouvant participer aux hernies au travers des points faibles.

b-face latérale

Lorsque la vessie se distend, les bords latéraux deviennent de véritable faces qui attirent le péritoine de face latérale du petit bassin déterminant ainsi deux

Diapositive 41

étages de rapports: étage sup péritonéal et étage
inf

s/péritonéal.

9-vascularisation-innervation

9.1-

arteres

La vascularisation provient essentiellement de l'artère iliaque interne:

a-

arteres

principales

S'organisent en pédicules largement anastomosés:

Pédicule sup formé par des rameaux de l'artère ombilicale et obturatrice, il est destiné au calotte.

Pédicule

inf

(pédicule du trigone) formé par l'artère vésicale inf.

Diapositive 42

b-artères accessoires

Proviennent des artères rectales moyenne et

srtt

des artères génitales:

Chez l'

hoe:les

artères

vésico

-prostatiques

Chez la femme: l'artère vaginale et utérine.

Au total, la vascularisation est riche et dépend du pédicule largement anastomosé.

9.2- les veines

Les réseaux muqueux et musculaires largement anastomosés se drainent:

En avant dans le plexus vésical de SANTORINI

en arrière dans le plexus utéro-vaginal.

Ces plexus gagnent les

vv

iliaques internes.

Diapositive 43

9.3-les lymphatiques

Ils gagnent les nœuds lymphatiques iliaques externes. Certains nœuds lymphatiques du col de la vessie gagnent le nœud du promontoire.

9.4-les nerfs

Les nerfs de la vessie proviennent de deux sources:

Le plexus hypogastrique

inf

Branche antérieure du 3

ème

et 4

ème

nerf sacré.

Ces rameaux destinés à la vessie cheminent dans les lames sacro-recto-génito

-pubiennes et abordent la vessie par sa base et faces latérales.

MERCI!

Diapositive 44

capitre4

uretre

1-

definition

L'urètre est un canal excréteur de la vessie. Chez l'homme, il a une double fonction urinaire et génitale. Chez la femme, une seule fonction urinaire.

Diapositive 45

2-

uretre

masculin

2.1-trajet d'ensemble

Très long, l'urètre s'étend du col de la vessie à l'extrémité du pénis. Il renferme 3 parties:

Partie prostatique: comprise entre le col de la vessie et l'apex de la prostate

Partie

membranacée

ou urètre membraneux qui traverse le diaphragme au niveau génital

Partie spongieuse: contenue dans le corps spongieux du pénis. Elle a 2 segments, un périnéal et l'autre pénien.

Au total, à l'état de repos, l'urètre dessine deux courbes:

Diapositive 46

Courbe postérieure(concave en haut et en avant)

Courbe antérieure(concave en bas et en arrière) à l'union des deux segments de la partie spongieuse.

Ces courbes peuvent s'effacer presque complètement en abaissant fortement sur le pénis.

2.2-autres subdivisions de l'urètre

On peut également subdiviser l'urètre selon:

1.la situation anatomique

Urètre postérieur regroupant l'urètre prostatique et membraneux;

Urètre antérieur correspondant à la partie spongieuse.

Diapositive 47

2-la

fixite

On a l'urètre fixe regroupant l'urètre prostatique, membraneux et le segment périnéal; l'urètre mobile contenant le segment pénien.

2.3-

dimensions

2.3.1-longueur

Elle est de 16cm environ lorsque le pénis est à l'état de flaccidité

:

3cm pour l'urètre prostatique

1-1.5cm pour l'urètre membraneux

12cm pour la partie spongieuse

Diapositive 48

2.3.2-calibre

lors de la miction, l'urètre présente 3 zones dilatées:

Sinus prostatique;

Cul-de-sac bulbaire

Fosse naviculaire:

4 zones rétrécies

Ostium

interne(col de la vessie)

Partie spongieuse moyenne

Partie

membranacée

Ostium

externe(

meat

urétral):zone la plus étroite(7cm).

Diapositive 49

Les parois de l'urètre sont extensibles, ce qui permet le cathétérisme instrumental.

2.4-structure

la paroi de l'urètre est constituée de 3 tuniques:

Une musculaire lisse en deux couches(interne et externe);

Une couche vasculaire spongieuse;

Une muqueuse très plissée de type cylindrique stratifié.

2.5-les rapports

L'urètre traverse la prostate située sur la base de la vessie et reçoit à ce niveau des canaux excréteurs de la prostate et des canaux éjaculateurs qui font suite au déférent et amènent le sperme.
C'est la partie prostatique de

Diapositive 50

l'urètre. A ce niveau se trouve le sphincter lisse.

La partie

membranacée

qui fait suite à celle-ci traverse le plancher pelvien

musculo

-aponévrotique dont fait partie le sphincter strié volontaire. L'urètre se coude en avant et s'entoure d'une gaine érectile qui l'accompagne jusqu'au gland

: c'est la partie spongieuse

.

3-

uretre

feminin

l'urètre chez la femme est plus court: 3-4 cm de longueur et 7 cm de diamètre qui traverse le plancher périnéal antérieur et va s'ouvrir en avant du vagin, en arrière du clitoris entre les deux petites lèvres qui circonscrivent le vestibule. Il comporte une

Diapositive 51

3.1- fixité

Il est fixé:

En arrière à la paroi antérieure du vagin;

En avant au pubis

L'urètre est divisé en deux: urètre pelvien et périnéal.

Diapositive 52

muqueuse, une musculeuse faite de 2 couches de muscles lisse et une séreuse.

Le sphincter lisse est situé juste au dessous de la vessie et le sphincter strié est plus bas situé.
Ce sphincter est volontaire.

vascularisation-innervation

1-chez l'homme

la partie prostatique est vascularisée par les branches de l'artère iliaque interne qui irriguent la prostate

La partie

membranacée

est

vascu

par l'artère rectale inférieure, l'artère du bulbe du pénis et l'artère vésicale antérieure(branche de la honteuse interne)

La partie spongieuse est

vascu

par les artères nées de l'artère honteuse

Diapositive 53

interne: artère du bulbe du pénis, artère dorsale du pénis et artère bulbo-urétrale

1.2-les veines

Elles sont tributaires de la veine dorsale du pénis et du plexus veineux prostatique de SANTORINI.

1.3-les

lymphatiques

Ils sont tributaires:

des collecteurs de la prostate pour la partie prostatique

Des nœuds iliaques interne et externe pour la partie
membranacée

;

Des nœuds iliaques externes inguinaux pour la partie spongieuse.

Diapositive 54

1.4- les nerfs

Ils proviennent:

Du plexus hypogastrique inférieur;

Des nerfs honteux par leurs deux branches: nerf périnéal et nerf dorsal du pénis.

2-chez

la

femme

2.1-les

arteres

L'urètre pelvien est

vascu

par l'artère vésicale inférieure et l'artère vésicale antérieure;

L'urètre périnéal est

vascu

par l'artère du bulbe du vestibule et l'artère bulbo-urétrale née de la honteuse interne.

Diapositive 55

2.2-les veines

Elles se jettent:

En haut dans le plexus veineux vaginal

En bas dans les

vv

bulbaires.

2.3-nerfs

Ils proviennent des nerfs honteux et du plexus hypogastrique inférieur.

merci

!

Diapositive 56

chapitre 5

la prostate

1-

définition

C'est une glande génitale impaire qui entoure la partie initiale de l'urètre chez l'homme, jouant un rôle dans l'élaboration du sperme.

2-situation anatomique

La prostate est située au carrefour des voies urinaires(qui la traversent) et des voies spermatiques (qui s'y terminent).

Diapositive 57

Elle repose sur le plancher périnéal dans l'écartement du muscle élévateur de l'anus:

Au dessous de la vessie;

En arrière de la symphyse pubienne (à 1.5cm)

En avant du rectum; elle est accessible au TR.

3-configuration externe

La prostate à la forme d'un cône à base sup auquel on décrit:

Une face

ant

plane, presque verticale;

2 faces latérales

Une face post convexe divisée en 2 par un sillon médian vertical;

Diapositive 58

Une base divisée en deux par un bourrelet transversal appelé lobe médian.

La partie antérieure de la base présente l'orifice de pénétration de l'urètre, la partie postérieure présente les orifices de la vésicule séminale et des ampoules déférentielles

qui se rejoignent à ce niveau pour former le canal éjaculateur et le sommet appelé bec prostatique.

4-configuration interne

La prostate contient:

Le sphincter lisse de l'urètre

L'urètre prostatique avec de verrues montanum (saillie longitudinale de la paroi)

Diapositive 59

urétrale postérieure) ou se terminent les deux canaux éjaculateurs de part et d'autre de l'utricule(rélicat

embryonnaire).

Les canaux éjaculateurs formés de chaque coté par l'union de déférent et de la vésicule séminale.

NB

:le

sphincter strié entoure l'urètre membraneux, le bec de prostate et remonte en s'étalant sur la face ant

de la prostate.

5-dimension

.

hauteur:3cm

Largeur:4cm

Épaisseur:3cm

Poids:15-25g.

Diapositive 60

6- structure

De consistance ferme, elle est constituée de tissus glandulaires de type tubulo-alvéolaire. Elle est entourée d'une capsule conjonctive, mince et adhérente envoyant des cloisons qui subdivisent la prostate en lobule glandulaire. Elle est traversée par divers organes qui cheminent dans les cloisons séparant les différents lobes.

NB

:la

prostate est constituée de 3 types de tissus: tissu glandulaire, conjonctif et musculaire.

7-

fixité

La prostate est particulièrement fixe amarrée:

Sa loge

Diapositive 61

Ses connexions avec l'
urètre, la

vessie et le périnée.

8-classification anatomique

8.1-classification classique

Trois lobes prostatiques dont deux latéraux et un médian.

8.2-classification de GIL VERNET

Il divise la prostate en 3 parties: prostate

craniale

, caudale et intermédiaire

Diapositive 62

8.3-classification de MAC NEAL

Il divise la prostate en 5 zones: la zone péri-urétrale, zone de transition, zone de stoma

fibro

-musculaire et la zone périphérique.

HBP se

dvpe

en grande partie à la partie péri-urétrale et de zone de transition ,

ie

prostate

craniale

selon GIL VERNET.

le cancer de la prostate se

dvpe

en grande partie dans la zone périphérique ou prostate caudale.

Diapositive 63

9-rapports

9.1-rapport avec la loge

Cette loge est épaisse, fibreuse et inextensible.

En avant: la lame

préprostatique

En arrière: la lame

prostatato

-péritonéale de DENOUVILLIERS

En bas: fascia sup du diaphragme uro-génital.

9.2-rapport a l'

interieur

de la loge

9.2.1-dans la loge

Le sphincter de la vessie ou sphincter lisse de l'urètre;

Diapositive 64

L'urètre prostatique

L'utricule prostatique (petit conduit médian postérieur à l'urètre)

Voies spermatiques constituées par les ampoules des canaux déférents et des vésicules qui s'unissent pour les canaux éjaculateurs.

9.2.2-autour de la prostate

Sphincter strié de l'urètre

Plexus veineux

périprostatique

situé dans les parois même de la loge et constituant un rapport chirurgical important.

10-vascularisation-innervation

Diapositive 65

10.1-

arteres

La prostate est

vascu

par les branches viscérales de l'artère iliaque interne:

Artère vésicale inférieure

Artère prostatique née souvent de l'artère

vésico

-prostatique

Qlq

rameaux de l'artère rectale moyenne.

10.2-veines

Elles se jettent dans le volumineux plexus séminale et prostatique(plexus de SANTORINI).

Deux courants rejoignent ensuite les

vv

iliaques internes:

Diapositive 66

Courant supérieur(pour la base de la prostate) par les vv

vésicales

Courant inférieur(pour les faces latérales) par les vv

honteuses internes.

10.3-les lymphatiques

Ils forment d'abord un réseau

périmprostatique.Ils

se résolvent en 3 pédicules de drainage:

Pédicule iliaque interne

Pédicule iliaque externe

Pédicule postérieur vers les ganglions sacraux.

10.4-nerfs

Ils viennent du plexus hypogastrique

inf.Ils

ont un double rôle: sécrétion glandulaire

Diapositive 67

et évacuation du liquide prostatique.

conclusion

La prostate est un organe génital impair de l'homme. Elle est, le plus souvent, le siège de plusieurs affections génitales et urinaires. La connaissance de son anatomie est importante pour la prise en charge des pathologies liées à cet organe.

merci

!